

31 - 01-révision sémiologie urologique (Teams) - Pr Lakmichi

Alors nous allons démarrer notre séance de révision. Je suis désolé pour le retard de dix minutes pour des raisons techniques. On était là un quart d'heure avant mais on ne pouvait pas contrôler les aléas de l'informatique.

Alors là on va démarrer la révision des cours de simbiologie urologique. Alors je présume que vous avez tous eu l'occasion de voir votre cours en détail. Alors ce sont des cours que nous avions tâchés d'être clairs et simples.

Et puis voilà avec des messages clairs à passer et surtout des messages à retenir d'ordre pratique. Alors après cette petite introduction, les douleurs en urologie, comme vous savez, c'est un symptôme qui est très fréquent en urologie. C'est un motif de consultation très fréquent.

Il peut concerner le haut appareil urinaire comme le bas appareil urinaire. Nous allons détailler ça. Alors là je ne vais pas reprendre littéralement le cours parce que je n'ai pas vraiment le temps pour ça.

Donc j'ai cinq à dix minutes par cours. Nous avons six cours, donc 60 minutes. Si on fait la division, ça fait dix minutes par cours.

Je vais essayer d'être bref pour chaque cours et d'aller directement vers les points clés de chaque cours. Alors le haut appareil urinaire, il peut être concerné par la douleur. Le meilleur symptôme, bien entendu, c'est la colique néphritique.

Nous allons voir rapidement. Le bas appareil urinaire aussi est concerné par la douleur, vessie, verge, prostate, bourse, etc. Alors ces douleurs peuvent être aiguës ou chroniques.

Vous connaissez pertinemment la définition de l'aiguë et du chronique à la différence. L'aiguë, bien sûr, c'est une douleur qui est intense et qui arrive de façon soudaine et brutale, qui prend quelques minutes à quelques heures pour s'installer. Une douleur chronique, bien entendu, c'est une douleur qui peut s'étaler sur plusieurs jours, des semaines, voire des mois.

C'est une douleur généralement qui est sourde, à titre de pesanteur, de lourdeur, à titre de gêne, etc. Et souvent ces douleurs-là sont accompagnées d'un certain nombre de symptômes urinaires, ce qui conduit à l'orientation vers tout ce qui est urologique. Ce sont des signes d'appel vers l'appareil urinaire et qui permettent d'orienter très souvent le diagnostic.

Le maître symptôme de la douleur du haut appareil urinaire, c'est la colique néphritique. Je crois que j'ai pris mon temps à sonoriser ce cours pour cette année, en expliquant en long et en large le syndrome de colique néphritique, qui est un syndrome douloureux lombo-abdominal aigu, résultant de la mise en tension brutale de la voie axiatrique du haut appareil urinaire en amont d'une obstruction. C'est un cours, comme vous le voyez, comme vous le constatez, de définition.

Je ne vais pas vous dire d'apprendre les définitions, je suis toujours partisan de la compréhension avant l'apprentissage, ça va vous faciliter énormément la tâche. Pardon, vous m'entendez maintenant ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur, on vous entend. Très bien, parfait.

Alors, c'est un cours de définition, comme j'ai dit, donc il faudrait retenir, mais avant de les apprendre, il faudrait les comprendre d'abord. Alors, comme j'ai dit, cette colique néphritique, elle ne présume en rien de la nature et les sièges d'obstacles. Autrement dit, quelle que soit la localisation de l'obstacle au niveau du haut appareil urinaire, c'est-à-dire de la tige calicelle, du bassinet, de la jonction piédiorhétérale, le long de l'urtère jusqu'au méa-urétéral, quelle que soit la localisation de cet obstacle à ce niveau-là, il va nous donner une mise en tension et une dilatation de la voie excétrice en amont de cet obstacle et donc ce qui va se manifester par, bien entendu, une douleur intense, aiguë, qui est la colique néphritique.

La plupart du temps, il s'agit du calcul urinaire et la forme simple est fréquente. Donc je ne reviendrai pas sur la posture du patient qui a une colique néphritique. Je reviendrai non plus sur l'irradiation de la douleur, c'est expliqué durant le cours sonorisé.

C'est une douleur qui irradie le long de l'urtère jusqu'à la région inguinale. C'est une douleur au niveau de la fosse lombaire, intense, avec élément important, absence de position antalgique. Autrement dit, le patient ne trouve pas de position qui soulage sa douleur.

Donc là, il y a les caractéristiques de cette douleur. Elle est bien entendu aiguë et automatiquement elle est brutale, du siège lombaire, immétérale, elle irradie le long de l'urtère, etc. Là, c'est un élément important, c'est l'évolution paroxystique.

Cette évolution paroxystique évolue par pics de douleurs intenses, des pics de douleurs intenses entrecoupés par des périodes de rémission, mais toujours sur un fond douloureux. Ces pics de paroxysme correspondent bien entendu aux pics de pression au niveau de la voie excétrice. C'est un moment où il y a des pics de pression au niveau de la voie excétrice.

N'oubliez pas que le rein continue à excréter les urines au niveau des voies urinaires. A chaque fois qu'il y a une poussée d'excrétion d'urine, il y aura une élévation de la pression, expliquant le paroxysme, le pic de pression entrecoupé de périodes de rémission de douleurs incomplètes. Absence de position antalgique, tout ça, ce sont des éléments importants des caractéristiques sémiologiques de la colique néphritique.

Il y a d'autres signes, notamment pour la curie, agitation, etc. Les signes physiques, contact lombaire, tympanisme, toucher pelvien sont très importants. Exceptionnellement, un calcul enclavé dans le méa urétéral, on peut éventuellement toucher une sensibilité du trigone, mais essentiellement chez la femme, en touchant le vagin, il peut déceler la présence d'une tumeur du col, d'un néo du col utérin.

Une tumeur du col utérin comprimant le trigone et les méas urétéraux. On peut tomber aussi sur un cancer de prostate, au cours du toucher rectal chez un homme, avec une prostate qui est dure et dure, expliquant la dilatation rénale en amont. Alors les étiologies, je les ai un peu survolées.

Là, ce n'est pas un cours de pathologie, mais juste pour avoir une idée. Là, on les a subdivisés en causes intraluminales, causes pariétales et causes extraluminales, surtout pour des raisons didactiques et pour mieux les retenir. Une cause intraluminaire, c'est tous les obstacles qui siègent à l'intérieur, c'est-à-dire au sein de la lumière de la voie excrétrice, comme par exemple les calculs rénaux ou calculs urétraux.

Ce sont des calculs qui siègent, bien entendu, au sein de la voie excrétrice, au sein de la lumière de la voie excrétrice, et donc ils vont obstruer. Comme une tumeur de la voie excrétrice aussi, une tumeur qui prend point de départ, c'est-à-dire la muqueuse urotéliale. Ces tumeurs-là vont comprimer la voie excrétrice et donner la douleur.

Les caillots sanguins aussi, qui peuvent être conséquents soit de la première cause ou de la deuxième, c'est-à-dire des calculs ou bien des tumeurs, peuvent causer un saignement au sein de la voie excrétrice et donc les caillots peuvent aussi donner ce symptôme-là. Les causes pariétales, il y a l'aténose congénitale de la voie excrétrice et le syndrome de jonction pilorotérale, où la jonction est complètement aténosée. L'explication histologique, c'est qu'il y a une absence de filets nerveux et des ganglions nerveux au sein de la musculature au niveau de la jonction pilorotérale et donc il y a l'absence de passage de l'influx nerveux à ce moment-là et il n'y a pas de parastase qui passe au niveau de la jonction pilorotérale et ça cause ce qu'on nomme le syndrome de jonction pilorotérale, c'est-à-dire qu'il y a une jonction qui est complètement aténosée et c'est une cause qui est congénitale à l'essence du bébé.

On peut remarquer cela. Cette aténose peut être incomplète, donc le patient peut la traîner avec lui le long de sa vie. Il y a aussi l'aténose urétrale.

L'urètre peut être soignée de causes infectieuses, spécifiques ou non spécifiques, causes post-traumatiques, etc. Et il y a les causes extraluminales qui sont les tumeurs rétro-péritoniales qui peuvent comprimer l'urètre ou bien même les tumeurs péritoniales, les tumeurs digestives, du colique, etc. qui peuvent comprimer l'urètre et causer une dilatation en amont, les adénopathies compressives, une fibrose rétro-péritoniale, bref, tout ce qui peut comprimer l'urètre vu son siège anatomique qui est rétro-péritonial et donc tout ce qui est devant lui, devant ses structures, pathologies tumorales, peut le comprimer et peut causer cette structure.

Alors pourquoi j'ai détaillé un petit peu cette diapositive ? Parce que je l'ai survolé au cours du cours sonorisé. Les signes de gravité à retenir, c'est la fièvre, la nuché, l'état de maladie néphritique, les signes péritoniaux, je crois que tout est clair. J'ai expliqué ça en long et en large au cours du cours sonorisé.

Les examens complémentaires, là, reprenez le maître-examen. S'il y a une chose à retenir sur cette diapositive, c'est que le maître-examen du symptôme du colique néphritique, c'est le scanner abdominopelvien non injecté, et que j'ai mis, entre parenthèses, uroscanner C-moins. Uroscanner C-moins, c'est ce qu'on prescrit sur les bancs.

On n'écrit pas scanner abdominopelvien non injecté, on écrit uroscanner C-moins, comme ça on oriente le radiologue vers ce qu'on veut avoir. Par contre, le couple échographie rénale à arburinaire sans préparation, ce sont des examens qui sont disponibles presque partout, qui sont peu coûteux, et qui peuvent éventuellement nous orienter, dans plus de 90% des cas, vers l'étiologie de la colique néphritique, surtout lorsqu'il s'agit d'une étiologie lithiasique. Cependant, le scanner est beaucoup plus performant que ça.

Les autres douleurs lombaires, on peut avoir des douleurs de reflux vésicorénales, les urines qui refluent de la vessie vers l'uretère, bien sûr en présence d'une anomalie de système d'antireflux au niveau de la jonction uretérovasculaire, et donc au cours de la miction, où il y a une hyperpression dans la vessie, les urines refluent le long de l'uretère vers le rein, et le patient généralement accuse cette douleur au cours de la miction. La pyoméphrite aiguë simple, ce sont des lombalgies simples, fébriles, etc., dans un tableau infectieux. Les tumeurs rénales, ça donne des pesanteurs lombaires, les traumatismes des reins, c'est assez évident comme étiologie, c'est simple à retenir.

Les douleurs du bas appareil urinaire, la première étiologie, c'est la rétention aiguë d'urine. Les douleurs d'origine vésicale, bien entendu, c'est la rétention aiguë d'urine, ça c'est un symptôme qu'on voit le plus souvent chez l'homme de la 6e ou 7e décennie, en rapport avec une hypertrophie bénigne ou maligne de la prostate. On peut le voir aussi chez les sujets jeunes, à cause d'une séquelle de l'urètre post-inflammatoire, post-gonococcique, ou bien lorsqu'il s'agit d'un calcul enclavé au niveau du col vésical ou de l'urètre.

Les cystalgies peuvent être aussi causées par des causes infectieuses et inflammatoires, en l'occurrence les cystites. Il y a les cystites bactériennes, un nom spécifique, qu'on voit le plus souvent chez la femme, deux à trois épisodes par année, c'est assez habituel et qu'on décrit le plus souvent, ce sont des cystites bactériennes. A l'opposé, on trouve des cystites spécifiques, c'est-à-dire d'origine tuberculeuse ou bilartienne.

Et il y a aussi les cystites non infectieuses, qui sont très rares éventuellement, et ce sont des cystites interstitielles, des cystites post-radicales. Ce sont des histologies, qu'on vous a vu, qui sont très simples à retenir. Les douleurs des organes génitaux externes, on trouve douleurs d'origine, bien sûr, scrotale.

On peut opposer l'aigu et le chronique. L'aigu, c'est essentiellement deux histologies, la torsion du cordon spermatique et l'orchépididymite, qu'on peut différencier par la présence ou non de fièvre et de signes inflammatoires au niveau scrotal. En l'absence d'une fièvre et de signes

inflammatoires au niveau scrotal, avec une douleur aiguë scrotale survenant chez un patient d'entre 13 et 18 ans généralement, c'est une torsion du cordon spermatique, jusqu'à preuve du contraire.

A l'opposé, lorsqu'il s'agit d'une douleur, bien entendu, tout aussi aiguë, chez un jeune patient ou d'un certain âge, avec des signes inflammatoires, un testicule ou un épididyme qui est augmenté de volume, c'est une archiepédyssimide, sauf qu'on ne doit pas tomber dans le piège de passer à côté d'une torsion du cordon spermatique parce que c'est une absence chirurgicale. Donc là, il faut faire une scrototomie, ouvrir le scrotum et explorer. Et comme on dit, le vieux adage, il vaut mieux faire une scrototomie sur une archiepédyssimide que de passer à côté d'une torsion du cordon spermatique parce que tout simplement, le patient va perdre son testicule avec ses conséquences sur la fertilité et des conséquences psychologiques.

La douleur chronique, c'est aussi facile à retenir. Il s'agit du cancer testicule. Le cancer testicule, c'est l'apanage des hommes entre 25 et 35 ans le plus souvent.

C'est un nodule testiculaire qui évolue à bas bruit, une douleur sourde. On peut même palper le nodule. Il y a aussi le varicocèle et l'hydrocèle.

Le varicocèle, par définition, c'est la dilatation variqueuse des cordons spermatiques causée par l'insuffisance valvulaire au niveau des veines spermatiques avec reflux du sang, soit à gauche de la veine rénale au niveau des veines spermatiques. Il y a la situation la plus fréquente et des exceptionnels à droite. L'hydrocèle, c'est la présence de liquide dans la vaginale, soit un liquide qui est au reflux du péritoine, en cas de persistance du canal péritoneo-vaginal, soit un liquide secondaire à des inflammations testiculaires, au bas âge, etc., qui s'est développé au sein de cette cavité virtuelle.

Là, c'est un schéma qui montre la torsion du cordon spermatique qui est supravaginale chez le nouveau-né et qui est intravaginale chez l'adolescent. Les prostatites, c'est un tableau qui est assez parlant, peut-être aigu ou chronique, mais surtout aigu qui est très parlant comme tableau. Bref, pour résumer cette diapositive, la prostatite aiguë, ce sont tous les troubles mixionnels associés à une fièvre, dans un tableau de fièvre, chez un homme.

Tout simplement, c'est assez simple comme tableau. Troubles mixionnels chez un homme. Évitez, s'il vous plaît, de toucher vos micros, s'il vous plaît.

Ça donne un son désagréable. Essayez, s'il vous plaît, d'être un peu à distance de vos micros. Alors, vous m'entendez toujours ? Oui.

Très bien. Oui, monsieur. Très bien, parfait.

Alors, donc, troubles mixionnels plus fièvre égale prostatite jusqu'à preuve du contraire. C'est ça. C'est ça le principal message à retenir de cette diapositive.

Je passe. Les douleurs de la verge, il y a les urethrites, l'inflammation urethrale. Alors là, j'ai l'impression de reprendre un petit peu le cours, mais je vais donc accélérer un peu.

Urethrite, c'est connu. Traumatisme de la verge, c'est connu comme étiologie. Alors, en conclusion, en conclusion, sachez que les douleurs en urologie, c'est un signe d'appel qui est très, très important, très intéressant, qui nous oriente vers la cause, l'étiologie de ces douleurs.

Donc, ils peuvent prendre des formes variables. Et donc, il faudrait savoir, il faudrait tout d'abord les connaître. En médecine, il faut savoir ce qu'on cherche.

Alors, pour savoir ce qu'on cherche, il faut d'abord connaître ce qu'on cherche pertinemment et par la suite, donc, détailler ce signe clinique et chercher l'étiologie parce que par la suite, ça a un impact sur la prise en charge, parce qu'après, vous allez demander des bilans radiologiques qui coûtent cher, des bilans biologiques, etc. Et si vous n'êtes pas bien orienté sur le plan clinique, vous allez complètement rater votre prise en charge. Et avec son impact économique, en termes d'économie de la santé, sur le patient et sur la société, donc, vous voyez l'intérêt d'asseoir le diagnostic qu'il faut et d'évoquer le diagnostic qu'il faut.

Et tout cela, c'est la base. La base, c'est la clinique. Il faut maîtriser la clinique, à savoir la séméiologie, l'examen clinique, etc.

Bon, je crois que c'est bon, là. Alors, vous me donnez une ou deux minutes pour passer l'autre cours, s'il vous plaît. Alors, rebonjour.

Vous m'entendez ? Oui, monsieur. Très, très bien. Alors, là, si je procède de la même manière dont je viens de faire avec le cours de la douleur, on ne va pas en finir.

Ça va aller jusqu'à 13 heures. Alors, ce que je veux faire maintenant, on va s'accorder cinq minutes pour ce cours de troubles mixionnels. Alors, vous affichez vos questions et moi, je vais essayer de répondre.

On va s'accorder exactement cinq à six minutes. Donc, essayez d'écrire vos questions sur des carpins à côté. Les questions qui sont brèves.

D'accord ? Et moi, je vais y répondre. Ok ? Essayez, s'il vous plaît, que tout le monde désactive son micro. Donc, je vais, là, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez enregistrer la séance.

La séance, déjà, elle est en cours d'enregistrement. Alors, essayez, s'il vous plaît, de mettre vos questions. Alors, en attendant d'avoir vos questions, je vais entamer les quelques points clés et les messages clés de ce cours.

D'accord ? C'est bien clair ? Désactivez tous et toutes les micros, s'il vous plaît. Alors, pour les troubles mixionnels, pour définir... S'il vous plaît, désactivez vos micros. Il y a un son désagréable qui émane sur la console.

Très bien, merci. Alors, là, pour définir les troubles de la miction, il faut d'abord connaître ce qu'est une miction normale. Alors, la miction normale, c'est en fait l'action d'uriner.

Elle doit être volontaire, c'est-à-dire l'être humain, donc, il décide d'uriner et il décide d'arrêter sa miction et d'uriner quand il veut. Donc, c'est un axe qui est volontaire et maîtrisé et maîtrisable. Un axe qui se passe sans douleur, indolore.

L'être humain, il urine, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Il effectue sans gêne, sans difficulté, d'accord ? Et selon une fréquence qui est compatible avec une autonomie suffisante entre deux mictions, ce qui permet une autonomie, ce qui permet une vie sociale correcte. Et il permet une évacuation vésicale complète, c'est-à-dire une vidange complète.

Tout cela, il se fait grâce au réservoir vésical qui se remplit en fonction, bien sûr, des apports hydriques et des pertes hydriques. Donc, il se remplit en moyenne entre 2 et 3 heures. Et il se vide, en principe, en 30 secondes.

Ce qui permet un élément important qui est le confort mictionnel. Alors, tout cela étant bien saisi et compris, par la suite, tout ce qui se décale de cette définition va tomber dans l'anormal, dans le pathologique. Et c'est ça la raison de ce cours, c'est-à-dire les troubles mictionnels.

Alors, je ne vois toujours pas de questions qui émanent. La polacurie, c'est une élévation, c'est une augmentation de la fréquence mictionnelle. Le patient se présente d'une façon, un nombre de fois qui est supérieur à la normale.

Au cours de la journée, tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, il se présente à la miction. C'est un problème de fréquence. Ça s'appelle une polacurie diurne.

Et la nuit, il se lève plus d'une fois. Une fois, on peut le tolérer, ça peut être normal. Mais au-delà d'une fois, deux fois, au-delà de deux fois plutôt, c'est anormal.

Ça devient une polacurie nocturne ou bien ce qu'on appelle une nicturie. C'est un motif de constatation qui est très, très fréquent, surtout chez des patients d'un certain âge. Généralement, ça oriente vers des troubles mictionnels en rapport avec l'hypertrophie bénigne à prostate, etc.

Il y a plein d'étiologies qu'on verra par la suite. Elles peuvent être légères, intermittentes ou intenses. Les étiologies, c'est une pathologie vésicale.

C'est l'instabilité de la trusorienne. Je ne vois toujours pas de question. Monsieur, c'est quoi la différence entre une forme simple et complexe de la colique néphritique ? J'aurais aimé avoir cette question le moment où je faisais le cours de colique néphritique, mais il n'y a pas de souci.

Il y a une diapositive sur le cours qui différencie entre le simple et le compliqué, c'est-à-dire les formes graves. Les formes graves, ce sont les formes compliquées. Les formes graves, c'est

l'aneurie obstructive, c'est la fièvre, colique néphritique associée à une aneurie obstructive ou bien associée à une fièvre ou bien hyperalgique, c'est-à-dire qui ne répond pas à un traitement autalgique bien conduit ou bien à une rupture de la voie excrétrice.

Ce sont des formes graves. Mais retenir essentiellement l'aneurie obstructive et la fièvre. Ce sont deux maîtres symptômes qui orientent vers la gravité de la colique néphritique et qui imposent une hospitalisation du patient dans un milieu spécialisé avec une levée d'obstacles, c'est-à-dire provendoscopique ou percutanée pour soulager les voies urinaires qui sont dilatées.

Très bien. J'aimerais avoir des questions plutôt sur les troubles mixionnels. Les troubles mixionnels, les étiologies, ce n'est pas un cours de pathologie, mais on ne peut pas faire la dichotomie.

Il faut toujours avoir des étiologies associées à ces symptômes pour avoir une certaine cohérence dans le raisonnement clinique. Cette polacurie peut être causée par une instabilité détruisorienne, c'est-à-dire le détruteur, le muscle vésical qui se contracte d'une façon incontrôlable. On dit, s'il vous plaît, désactivez vos micros, s'il vous plaît.

Merci. Il y a aussi la pathologie prostatique qui est très fréquente. Et les vessies de capacité diminuées, c'est assez rare comme étiologie.

Et les désordres psychosomatiques des patients qui se mettent à boire de façon anormale, dans un tableau psychiatrique. C'est une bonne question. C'est une excellente question.

Le cancer de la prostate, c'est une tumeur. C'est une augmentation de volume de la prostate qui est anarchique, qui est désorganisée, qui obstrue le col vésical et le rectum prostatique. Et c'est un obstacle qui est, on dit, sous-vésical, et qui s'oppose à la bonne vidange de la vessie.

Donc la vidange vésicale est complètement compromise dans un certain nombre de cas où la prostate augmente du volume de façon très importante. Ça, comment expliquer la désiorie ? Alors comment expliquer l'urgentiorie ou la polacurie ? Alors là, la tumeur prostatique, il va envahir le trigone vésical. Alors quand elle va envahir le trigone et la base de la vessie, souvenez-vous des connaissances anatomiques, la prostate qui a des rapports très très intimes avec le col vésical et la base de la vessie, et donc il va envahir cette vessie, cette vessie qui est constituée par le détruteur et qui va donc irriter cette paroi vésicale et va être source d'irritation et d'instabilité détruisorienne et qui va donner ce tableau de polacurie.

Parce qu'on a un petit peu traité signe symptôme par symptôme pour des raisons didactiques. Mais généralement, une seule pathologie, il y a généralement plusieurs symptômes associés. L'hypertrophie bénigne prostate, on peut trouver la désiorie, la polacurie, l'urgentiorie, même la rétention aiguë d'urine, etc.

La polacurie, l'annexurie, etc. Donc une seule pathologie. Voilà, donc je passe.

J'attends toujours vos questions. Il nous reste deux ou trois minutes pour ce cours. Les diagnostics différentiels, c'est la poliorie.

Quand on boit, bien sûr, abondamment, la vie s'il y a une capacité limitée de 300 cc. Donc on doit vider ces 300 cc pour recevoir 300 cc, autre quantité d'urine pour la vider. C'est une capacité qui est limitée.

Et donc, il ne peut pas répondre à un débit urinaire qui est très, très élevé. Il faut donc la vider à chaque fois. La dysurie, c'est connu comme définition.

C'est très simple. Vous l'avez vu sur le cours sonorisé. C'est une mission qui est lente, pénible, plusieurs temps et qui nécessite des poussées abdominales.

Des poussées abdominales pour arriver à vider la vessie. C'est la définition de la dysurie. Voilà.

Le symptôme, c'est un G urinaire qui est faible, lent, avec des poussées, etc. Alors, la dysurie, on peut l'évoluer cliniquement, comme ça. Le patient qui urine devant vous, vous voyez que le G urinaire qui est très, très faible, ou bien c'est rapporté par le patient, ou bien on peut l'objectiver par la mesure du débit urinaire, ce qu'on appelle la débitmétrie.

C'est un appareil où le patient urine et qui vous donne, à la fin de la mission, il vous donne le vrai débit du patient. Une dysurie qui est nette, c'est un débitmétrie inférieur à 10 ml par seconde, et sévère lorsqu'elle est inférieure à 5 ml par seconde. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des exemplaires d'AQCM ou bien des cas cliniques d'urologie ? Merci d'avance.

Oui, ce n'était pas prévu pour cette séance. C'est surtout prévu de voir un petit peu les symptômes. Peut-être que je reprogrammerai une autre séance interactive, peut-être en fin de semestre.

Incha'Allah. Très bien. Alors, les idéologies, c'est de la dysurie, tout obstacle du bas appareil urinaire, tout obstacle sous-physical, obstacle prostatique, tendance du retre, tendance du col vésical, calcul enclavé au niveau du col vésical, hypoactivité vésicale.

Là, c'est un autre chapitre qui est l'hypoactivité vésicale, c'est-à-dire un détruteur qui est très fatigué. Il n'y a pas de contraction. Vraiment, les contractions vésicales sont très, très faibles et qui n'arrivent pas à pousser les urines à travers le col et le retre vésical.

Ça arrive chez les sujets âgés, chez les grands diabétiques. Et il y a des causes neurologiques, congénitales ou acquises, je passe. L'urgenturie, c'est clair, c'est l'obligation d'uriner dans les secondes qui suivent, la perception du besoin.

Les idéologies, vous allez trouver pratiquement les mêmes idéologies pour l'urgenturie. C'est toutes causes qui irritent la vessie, à savoir pathologie prostatique, hypertrophie bénite de la prostate concernant la prostate, ou bien une pathologie inflammatoire de la prostate, une

prostatite, ou bien une pathologie infectieuse de la vessie, une cystite, une inflammation vésicale. Les calculs de vessie, causes neurologiques, sclérose en plaques, etc.

Les fuites, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est la séance de révision. Tout ce qui reste un peu flou dans vos esprits, en suspens, je suis là pour l'éclaircir et pour lever toute ambiguïté dans le cours. Alors les fuites urinaires, on peut les diviser en deux.

Il y a tout d'abord les fuites urinaires par les orifices anatomiques, c'est l'incontinence urinaire, le patient n'arrive pas à se retenir, c'est clair, c'est connu. Et les fuites urinaires vaginales ou autres, par les orifices extra-anatomiques, les orifices extra-urinaires, qui peuvent être de cause de pathologie qui est la fistule urogénitale, vésicovaginale ou exceptionnellement urétérovaginale. Le type de l'incontinence qui est l'incontinence d'effort, donc fuites urinaires par le mer urétérale à l'occasion d'un effort de toux ou lèvement de charges, c'est l'incontinence urinaire d'effort.

Et les fuites urinaires permanentes par le mer urétérale, par insuffisance sphinctérienne généralement. Les fuites urinaires par fistule urogénitale, il y a fistule vésicovaginale, fistule urétérovaginale, je ne vais pas rentrer dans ces détails, l'essentiel ce sont des fuites urinaires avec perte de la miction pour les fistules vésicovaginales, retenez ça essentiellement. La purise, la présence de pus dans les urines, je ne vois toujours pas de questions, alors s'il vous plaît n'hésitez pas à poser vos questions.

Alors l'ématurier, je saute pour l'ématurier, c'est la miction d'urine, meulet, du sang, c'est un élément siméologique qui est très très important et qui oriente vers des pathologies généralement, pathologie grave, pathologie tumorale, tumeur de vessie, tumeur de la voie excétrice, ou bien une pathologie bénigne, à savoir la pathologie litiasique, présence de calcul dans la voie excétrice ou dans la vessie qui hérite la muqueuse vésicale avec un saignement au sein de la lumière vésicale. Donc ça impose toujours une enquête étiologique bien entendu, à savoir des examens endoscopiques, des examens d'imagerie, du re-scanner, etc. L'examen positif, le diagnostic positif, pardon, c'est le fait de prouver la présence de globules rouges avec un nombre très important dans les urines.

Et le diagnostic topographique, sur le plan siméologique, on parle d'ématurie initiale lorsqu'il s'agit d'une origine uretroprostatique, une ématurie terminale lorsqu'il s'agit d'une origine vésicale, et une ématurie totale, ça n'a pas de valeur localisatrice. Pourquoi ? Parce que s'il y a un saignement abondant, que ce soit de la vessie ou de la voie excétrice supérieure, on n'arrive pas donc à se situer sur le plan clinique par rapport à l'organisation du saignement. Voilà.

Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Monsieur Makram Boukrim, pouvez-vous expliquer la fistule urétéro-vaginale et qu'est-ce que veut dire conservation d'une miction normale ? Oui. Quand vous avez remarqué, je n'ai pas trop insisté sur cette diapositive. Le principal message que je voudrais que vous reteniez, c'est par rapport à la fistule vésico-vaginale.

La fistule vésico-vaginale, c'est une communication de la paroi vésicale à la lumière... Communication de la lumière vésicale et de la lumière vaginale à travers un orifice au niveau de... à ce niveau-là. Et les urines passent de la vessie vers le vagin, ce qui crée une incontinence par orifice extra-anatomique. La vessie se vide complètement et, par conséquent, la patiente n'arrive pas à avoir une miction qui est normale, c'est-à-dire n'arrive pas à remplir sa vessie pour qu'elle puisse uriner normalement.

Par contre, la fistule entre urtère et vagin, c'est exceptionnel, il faut même l'oublier. C'est assez exceptionnel comme pathologie. Les urines passent de l'urtère directement vers la paroi vaginale.

Et il y a l'autre urtère qui remplit toujours la vessie et la patiente garde la miction, garde sa miction. C'est assez exceptionnel comme mythologie, mais que je garde entre parenthèses. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est surtout le tableau de la fistule vésico-vaginale.

Très bien. Monsieur, est-ce que l'incontinence urinaire est normale en post-opératoire, en post-opération viscérale ? Et donc, elle ne relève pas toujours d'une pathologie. L'incontinence urinaire est normale.

Alors, il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas... C'est mademoiselle Imen. Alors, il ne faut pas, généralement, en post-opératoire... En post-opératoire, généralement, les patients, ils ont une sonde vésicale. Ils ont une sonde vésicale qui a séjourné pendant quelques jours dans la vessie.

Cette sonde vésicale a créé une inflammation de la paroi vésicale, une irritation. Et ça peut causer une instabilité détrusorienne avec des fuites, avec des contractions désinhibées de la vessie. Ce ne sont pas de véritables... Ce n'est pas une véritable incontinence.

Et généralement, ça rentre dans l'ordre au bout de quelques semaines. Donc, ce n'est pas une véritable incontinence. Très bien.

C'est une dénonciation topographique. Excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, l'examen d'imagerie, c'est assez clair, je crois.

Examen endoscopique, c'est assez clair. Les idéologies, les causes d'hématurie sont assez claires, je crois. Causes tumorales, causes infectieuses et inflammatoires.

Causes générales, troubles de l'hémostase, de la crasse sanguine, des causes néphrologiques. Il faudrait différencier entre l'hématurie d'origine urologique et l'hématurie d'origine néphrologique. Moi, je ne voudrais pas commencer par un cas clinique parce que j'aimerais plutôt aller dans le fond du cours, disséquer les choses à apprendre du cours, avec des messages qui sont clairs, pour être mieux armé pour les cas cliniques.

Généralement, ça se programme sur deux séances. Une séance pour les cours, véritablement, et une autre séance pour le cas clinique. Mais je voudrais faire avec vous, bien entendu, avec grand plaisir, un effort de reprogrammer une autre séance avec des cas cliniques, si vous voulez bien.

Très bien, parfait. Alors, voilà, l'hématurie, c'est assez clair. L'urésie, c'est bon.

Le butlage mictionnel, c'est assez parlant. Donc, j'aimerais répondre à vos questions. Alors, monsieur, est-ce que l'incontinence, c'est bon ? Monsieur Ziad Sadri.

Monsieur, pourquoi une hématurie d'origine physique dans du sang en fin de miction et non pas au début ? Alors, c'est ce genre de questions que j'aimerais avoir. Alors, ce genre-là et aussi les autres questions d'autres étudiants et étudiantes, c'est bien, ça démontre que vous raisonnez un petit peu, vous revoyez vos cours et vous moulinez un petit peu les idées. Ça, c'est une très, très bonne chose parce que là, mon rôle, c'est en fait de corriger le mécanisme de raisonnement, pas uniquement de gober les informations comme ça.

Moi, je voudrais que vous ayez une thèse bien faite et aussi pleine. Pourquoi pas ? Très bien. Alors là, pourquoi l'hématurie d'origine physique dans du sang en fin de miction ? Alors, parce que, tout simplement, lorsqu'il s'agit d'un saignement d'origine physique et le plus souvent, il s'agit d'une tumeur de vessie, le plus souvent, tumeur de vessie ou bien une inflammation physique ou une cystite, c'est après l'évacuation de la majeure partie des urines claires que survient le saignement, que survient le saignement de cette tumeur ou de cette paroi physique enflammée par le tableau de la cystite.

Donc, c'est en fin de miction et que les parois de la vessie se collabent que se produit le saignement et qui s'évacue avec le reste des urines. A l'opposé, lorsqu'il s'agit d'un saignement actif, abondant au sein de la lumière vésicale, d'emblée, on aura l'hématurie au cours du premier jet urinaire. C'est ce genre de nuance que je voudrais éclaircir et faire de la lumière ce genre d'idée.

C'est bien pour mieux retenir. Parfait. Très bien.

Je crois qu'on passera au cours suivant. Merci. Très bien.

Vous arrivez à voir l'examen physique en urologie ? Oui. Très bien. Merci.

Alors, l'examen physique en urologie, après avoir vu quelques symptômes, quelques syndromes simbiologiques urinaires, l'examen urologique. Comme vous voyez, on a fait l'anamnèse. On a vu les principales symptômes, les signes fonctionnels rapportés par le patient.

Et là, c'est le temps de l'examen, c'est-à-dire le temps des signes physiques qu'on va trouver nous-mêmes à travers l'examen clinique du patient. Le palpé, la palpation, le touché,

l'auscultation, etc. Tout ça, ce sont des signes physiques.

Avant, c'était des signes fonctionnels, c'est-à-dire des signes qui sont rapportés par le patient à travers l'anamnèse. Alors, l'examen physique en urologie. Excusez-moi une seconde.

Tout d'abord, il y a l'examen des fausses lombes. Alors, s'il vous plaît, essayez d'émettre vos questions assez rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. En principe, la séance est finie.

Alors, l'examen des fausses lombes. Rapidement, tout d'abord, avant tout l'examen clinique, il faut expliquer aux patients ce qu'on va faire. D'accord ? Il faut expliquer aux patients ce qu'on va faire parce que les patients sont parfois choqués devant des gestes inopportuns à travers des examinateurs qui ne sont pas très attentionnés.

Ce n'est pas bien. Donc, il faudrait expliquer aux patients ce qu'on veut faire, la position de l'examen, etc. Donc, il faut, parce que tout cela, pourquoi ? Pour mettre en confiance votre patient.

Et du moment que votre patient est mis en confiance, il y a une meilleure adhérence, donc observance à l'examen clinique, etc. Donc, l'examen des fausses lombes. Tout d'abord, la position.

C'est un patient qui se met en position assise avec le dos qui est découvert, donc avec une torse nue, idéalement. Et ça commence par l'inspection, par la suite, la palpation, l'auscultation, etc. Il y a deux principaux symptômes qu'on peut déceler lors de l'examen des fausses lombes, qui est le contact lombaire, le ballotement rénal.

Donc, contact lombaire, c'est assez clair. C'est la main qui est posée au contact de la fausse lombes qui palpe une masse qui est poussée par la main qui est positionnée au niveau de l'hypocampe qui pousse cette masse, et cette masse vient en contact de la main postérieure au niveau de la fausse lombes. Donc, pour avoir ce contact, la masse vient au contact de cette main et donc on parle de contact lombaire.

Alors la position, j'ai parlé de position assise, torse nu, c'est pour l'inspection. C'est très important. Je reviens à l'inspection.

Pourquoi ? Parce qu'il faut inspecter, il faut voir s'il n'y a pas de cicatrices, de l'embotomie, c'est-à-dire une incision pour une voie d'abord rénale, etc. dont les antécédents, qu'on risque d'oublier. Et la position à l'examen, c'est-à-dire de la palpation, c'est bien entendu le décubitus dorsal, les jambes fléchies, les bras le long du corps.

Et on se positionne du côté de la fausse lombes qu'on voudrait examiner. Donc avec une main postérieure et une main antérieure. C'est pour cela qu'on parle, en présence d'une masse lombaire, on parle de contact lombaire, ça c'est déjà expliqué, de ballotement rénal.

Ballotement rénal, il s'agit d'une masse rénale. Cette masse, en fait le va et le vient de cette masse. La main postérieure pousse la masse et elle va buter contre la main antérieure et vice-versa.

La main antérieure va pousser la masse et elle va buter contre la main postérieure. Généralement, ce sont des signes qui sont associés. C'est une masse qui est barrée en avant par la sonorité colique.

C'est assez exceptionnel qu'on le trouve, mais c'est une description simiologique qu'on doit citer. Ça c'est la palpe à billes manuelle, comme vous voyez. Ballotement rénal, on ballote les reins, le rein ou la masse rénale.

La percussion pour la sonorité colique, mais sur le plan pratique, on ne fait pas ça. C'est surtout le ballotement rénal qu'on contacte lambert. Les étiologies, c'est toute étiologie conduisant à une augmentation du volume du rein, à savoir une hydronéphrose, qui est une dilatation de la voie excrétrice rénale, des cavités pilocalicielles, en rapport avec un obstacle, etc.

Une tumeur rénale, présence de kystes rénaux simples ou bien une polykystose rénale, c'est-à-dire présence de plusieurs kystes au niveau des deux reins. Et chez l'enfant, les tumeurs rénales, essentiellement de fréquence, le néphroblastome. Alors essayez s'il vous plaît de mettre des questions, parce que là, je vais un petit peu survoler le cours pour voir un petit peu les messages clés.

L'examen de l'hypogastre, c'est surtout après vidange vésicale qu'on fait cet examen. Et en cas de rétention augustin, c'est une masse suspubienne qui est arrondie, à convexité supérieure et mat à la percussion. Là, c'est un globe vésical que vous voyez.

Toucher pélvien, c'est un temps primordial lors de l'examen clinique. Toucher pélvien, c'est très très important. Ça peut nous donner des renseignements qui sont d'une extrême importance pour la prise en charge du patient.

Toucher pélvien chez l'homme, c'est le toucher rectal, et chez la femme, c'est le toucher rectal et le toucher vaginal. Et parfois, deux touchers combinés chez la femme. Le toucher rectal permet de percevoir bien entendu la prostate.

On doit l'étudier, étudier sa surface, etc. Prostate qui est hypertrophiée de façon homogène, c'est une hypertrophie binnée de la prostate, qui est souple et élastique, à l'opposé du cancer de la prostate. Généralement, au stade avancé, on trouve un nodule ou bien une prostate qui est dure et endurée.

À savoir que le toucher rectal n'écarte pas le cancer de la prostate. On peut avoir un tout petit nodule enclavé dans le parachute prostatique et passé à côté, qui est avec une prostate pratiquement normale. Ça c'est entre parenthèses.

La prostatite ou le toucher rectal c'est une prostate qui est très douloureuse. C'est un signe clinique qui est très important, qui confirme la prostatite. C'est un malade qui perçoit une douleur très aiguë, très importante, lors du toucher.

Il faut éviter généralement les massages prostatiques lors des prostatites. Là c'est un toucher combiné, toucher rectal combiné, avec le palpé. Toucher pévien chez l'homme, toucher rectal sans la vue.

Là c'est un schéma qui montre le toucher vagina sur plan anatomique, les structures qu'on arrive à toucher, essentiellement l'urètre et le trigone vésical. Voilà. L'examen des organes génitaux externes, je crois que c'est pas vraiment difficile de comprendre tout ça.

On l'a sonorisé. Là il faut chercher un phimosis chez l'enfant, c'est-à-dire un anneau fibreux au niveau du prépuce, en avant du gland. Le traitement, c'est la circoncision.

L'examen des organes génitaux externes chez l'homme. Alors je ne vois toujours pas des questions pour avancer. Alors... Monsieur, pourquoi une hématurie ? Comment ces trois examens peuvent nous renseigner sur un grand rat ? Et non pas une tumeur par exemple.

Tumeur de quoi ? Je ne sais pas. Tumeur de quelle origine ? Bon. Monsieur, veuillez donc reformuler votre question s'il vous plaît.

C'est pas tellement clair. Très bien. Les organes génitaux externes.

Alors si vous n'avez pas de questions, ça c'est clair. si vous n'avez pas de questions là-dessus, je passe. Examen de la mixtion, c'est assez clair.

Je ne vais pas reprendre les cours. Sachez que l'examen clinique en urologie est une étape fondamentale dans l'établissement d'un diagnostic approprié qui doit conduire à une application doit être conduit avec application pour ressortir des éléments objectifs. Il faudrait savoir maîtriser l'examen urologique afin de ne pas passer à côté d'une pathologie grave.

Voilà. Je vais passer à l'autre cours rapidement. Mais il n'y a pas de souci.

Posez vos questions même s'il s'agit d'autres cours qu'on a vus. Il n'y a aucun problème. Je peux répondre.

Vous arrivez à voir l'examen complémentaire en urologie? S'il vous plaît. Très bien. Parfait.

Merci. Je parle du contact lambaire, du balottement et de la sonorité colique. C'est dit au niveau du cours que ça évoque un grand rein.

Oui, ça évoque un grand rein. C'est une tumeur rénale, un rein polycystique, etc. Il s'agit bel et bien du rein qu'on palpe.

Un rein qui est augmenté de volume qu'on palpe. Oui, c'est un grand rein. Ce sont des signes qui orientent vers le grand rein.

Quelles sont les causes de l'urgenturie? Les causes de l'urgenturie, c'est mentionné sur le cours. Mademoiselle Sonia Kangmu. C'est mentionné sur le cours.

Toutes causes qui irritent la vessie, que ce soit l'hypertrophie bénigne de la prostate, cancer de la prostate, prostatite, calcul de vessie, les cystites, tout ça peut être une cause d'urgenturie. Mais pourquoi pas autre chose? Bon, veuillez reformuler vos questions, s'il vous plaît. Très bien.

Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça peut être un autre problème qu'un grand rein? Éventuellement, on peut tomber sur une grosse masse rétro-péritoniale, mais son comportement n'est pas vraiment comme le grand rein lorsqu'il s'agit d'une tumeur rénale. On peut avoir une grosse masse rétro-péritoniale, sarcomatose, etc., une masse abdominale, mais il n'est pas autant mobilisable que la masse rénale. D'accord? C'est ça la différence.

Monsieur, comment on peut faire la différence entre une hernie inguinale et une hydrocèle cliniquement? Alors, cliniquement, l'hernie inguinale, généralement, elle est réductible. L'hydrocèle, elle ne l'est pas. Sauf lorsqu'il s'agit d'une persistance du canal péritonio-vaginal.

Même en présence d'une hydrocèle, dans ce cas, vous pouvez la réduire, mais généralement, il y a des explorations aussi paracliniques. On parle de la transillumination. C'est une torche qu'on met au niveau de la bourse qui est augmentée de volume.

Si la lumière traverse, c'est du liquide. Si elle ne traverse pas, ce sont les enceintes intestinales, mais généralement, cet examen est dépassé. C'est l'échographie qui fait la différence.

Donc cet examen n'est pas spécifique juste au grand rein. Non, moi, j'ai éliminé toutes les causes des autres étiologies qui peuvent prêter à confusion entre le grand rein et les autres masses et j'ai laissé le contact lombaire et le balottement rénal juste pour les grands reins. Pourquoi? Parce que ce contact lombaire et ce balottement rénal, on peut dire qu'il est spécifique au grand rein, mais parfois, et exceptionnellement, on peut tomber sur des tumeurs qui sont un petit peu mobilisables, une tumeur de l'ongle colique, etc., mais pas autant que le grand rein.

Alors, vous avez deux questions concernant les examens complémentaires? Parce qu'on n'a pas... C'est bon, on a largement dépassé l'heure de... Très bien, j'espère que j'étais bien clair, monsieur Mouha Olesri, parce que on fait un effort énorme pour simplifier les choses et être très didactique, mais la médecine, c'est très... C'est pas une science exacte, mais on voudrait vous orienter vers les trucs et astuces pour être plus performant sur le plan clinique. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant les examens complémentaires en matière de urologie? Alors, les examens complémentaires, sachez-le, ils occupent une place très, très, très importante de nos jours. Ce sont des examens qui sont devenus très performants, très spécifiques, qui orientent et qui confirment plutôt les diagnostics, mais il faudrait être bien armé pour poser

l'indication de ces examens, pour ne pas prescrire à tort et à travers ces examens, demander à la fois des choses qui sont très chères et peu disponibles pour avoir des diagnostics qui sont très évidents sur le plan clinique, ou avec des examens paracliniques qui sont assez disponibles.

Et puis, voilà, donc, c'est une étape qui est très, très importante, comme j'ai dit, pour l'établissement des diagnostics. Ce sont des examens radiologiques et des examens biologiques. Ce n'est pas un cours de biologie, ni un cours d'imagerie, de radiologie, mais juste pour attirer votre attention sur les principaux examens paracliniques qu'on demande en urologie.

Je crois que le cours était très, très clair. Je l'ai sonorisé d'une façon très, très simple. Voilà.

Donc, si vous avez des questions, je peux répondre. Sinon, je passerai à l'autre cours, parce que pour reprendre tout le cours, il me faut beaucoup de temps. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser vos questions, même concernant les autres cours, à savoir les grands reins, les grosses bourses.

Il n'y a aucun problème. Alors, vous voyez le cours des grands reins? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Est-ce que vous avez des questions concernant le cours des grands reins? Ou sinon, les autres cours.

Il n'y a aucun problème. On a plus que cinq minutes, parce que normalement, on doit finir à 11h30. On n'a pas démarré tôt.

Donc, on a dix minutes de retard. On l'a pris en compte. Et donc, on est largement au-delà de... On est dix minutes au-delà du temps imparti à cette révision.

Mais il n'y a pas de souci. Je prendrai vos questions volontiers. Il n'y a aucun souci.

Il n'y a aucun problème. J'attends vos questions. Le cours des grands reins, c'est assez clair comme cours.

Il n'y a pas de souci. Je prendrai vos questions assez volontiers. Et comme j'ai dit, je ferai un effort supplémentaire avec les responsables de cette plateforme pour aussi reprogrammer une autre petite séance de révision.

Il y aura peut-être des cas cliniques. Deux ou trois cas cliniques aussi. Essayons de résumer un petit peu la sémiologie.

Et aussi, allons vers les examens complémentaires. Permettons d'avoir une idée à propos des examens complémentaires, comment on les fait. On pose l'indication, etc.

Ça, ce sera une bonne chose. Mais bien entendu, on doit se plier à la programmation ici à la fac. S'il y a une heure de libre, je vais volontiers, avec grand plaisir, reprogrammer une autre séance de cas cliniques.

Donc, s'il vous plaît de mettre... On a plus que deux ou trois minutes. Parce que là, je suis un peu

pressé par le temps. Et puis, voilà.

Alors, si je ne vois pas de questions sur cette liste-là, je crois que tout est clair. Chapitre Gros Rhin, comme vous voyez, pour répondre au monsieur qui se posait la question est-ce que contact Lambert-Volotte-Morenal répondait strictement aux étiologies des grands rhins? Clairement, non. Mais moi, je vous ai orientés vers cette pathologie des grands rhins parce que c'est là où vraiment ce signe clinique se manifeste et on voit son importance.

Lorsqu'il s'agit d'une tumeur rénale, un rhin qui stique, une énorme hydronephrose majeure, ce contact Lambert-Volotte-Morenal, c'est là vraiment où on voit son utilité et qu'on colle ces signes cliniques de baladement rénal de contact Lambert et nous oriente vers la masse rénale de façon assez spécifique. Les grosses étiologies, des grands rhins, une tumeur rénale, un cancer du rhin, qui est un carcinome à cellules rénales le plus souvent, et l'autre étiologie, c'est les rhins qui stiquent, que ce soit une polykystose ou les kystes simples géants. La dernière étiologie, c'est l'hydronephrose.

C'est essentiellement ça, mais ma question ne sera pas une question d'examen, les examens ne seront pas orientés, bien entendu, spécifiquement vers les types de pathologies vraiment qui sont exceptionnels, mais ce sont des questions qui sont claires, qui orientent vers les principales étiologies. Les questions d'examen ne sont pas faites pour vous coincer, mais surtout, ils sont orientés vers des messages qui sont assez clairs, assez pertinents et qui ont un impact très positif sur votre pratique future. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.

J'ai encore une minute. Le cours des grosses bourses c'est assez clair aussi, il faut différencier entre grosses bourses aiguës, grosses bourses chroniques. La grosse bourse aiguë, comme on l'a vu au départ, c'est lorsqu'il y a l'épidémie, c'est la torsion.

Il faut favoriser beaucoup plus la torsion du corps dans la spermatique parce que c'est une urgence chirurgicale. Et la grosse bourse chronique, c'est bien entendu tout ce qui est penchement lichysien dans la bourse, hydrocèle, tout ce qui est kystépidimère, tout ce qui est varicocèle, nous avons vu ce qu'est la varicocèle, etc. Je crois que les choses sont claires cliniquement et par la suite viendra le rôle des examens paracliniques, en l'occurrence l'imagerie et en particulier l'échographie pour faire la part des choses en matière de grosses bourses.

Une masse tissulaire bien entendu c'est une tumeur testiculaire et lorsqu'il s'agit du liquide c'est une hydrocèle ou un kystépidimère, etc. Je crois que les choses sont très claires, nous avons abordé le cours d'une façon très claire et pédagogique et je suis toujours à votre écoute, éventuellement vous pouvez m'envoyer des e-mails si vous voulez sur mon e-mail aminelakmichi at yahoo.com ou bien amine avec e .lakmichi at gmail.com Je suis à votre écoute, il n'y a aucun souci vous pouvez m'envoyer vos e-mails, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît monsieur, est-ce que vous pouvez écrire votre e-mail sur la conversation ? Je vais essayer, bien sûr, avec grand plaisir.

Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Je vais écrire... C'est bon, vous l'avez ? Oui monsieur, merci beaucoup.

Je vous en prie. Très bien, ça c'est la page 8 heures. Très bien.

Je vous souhaite un très très bon courage et je vous promets de faire un effort de ma part pour reprogrammer une autre séance de cas cliniques, chose qui me tient à cœur pour faire le point. Pourquoi j'ai revu ces cours ? Parce que comme j'ai dit au départ, il faudrait disséquer un petit peu ces cours, on n'a pas eu l'occasion malheureusement du fait de cette pandémie d'avoir un contact direct au cours des cours de magistraux qui nous manquent vraiment. Et parce qu'il faut revoir cette base.

Pour moi, la base ce sont les cours. Il faudrait avoir une bonne compréhension des cours et il faut que vous soyez bien outillés sur le plan raisonnement clinique. Ça c'est très très important à mon sens.

Une fois que vous serez bien outillés, armés sur le plan connaissances pédagogiques, vous allez voir que les cas cliniques ça serait vraiment très très facile. Surtout l'urologie, c'est le raisonnement clinique. Vous allez arriver à vous en sortir très très très bien.

J'en suis sûr. Je vous ai laissé mon email et ma page Twitter pour si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Il me reste à vous remercier pour votre attention et votre interaction.

Nous restons toujours à votre disposition et à votre écoute. Bon courage et à bientôt.